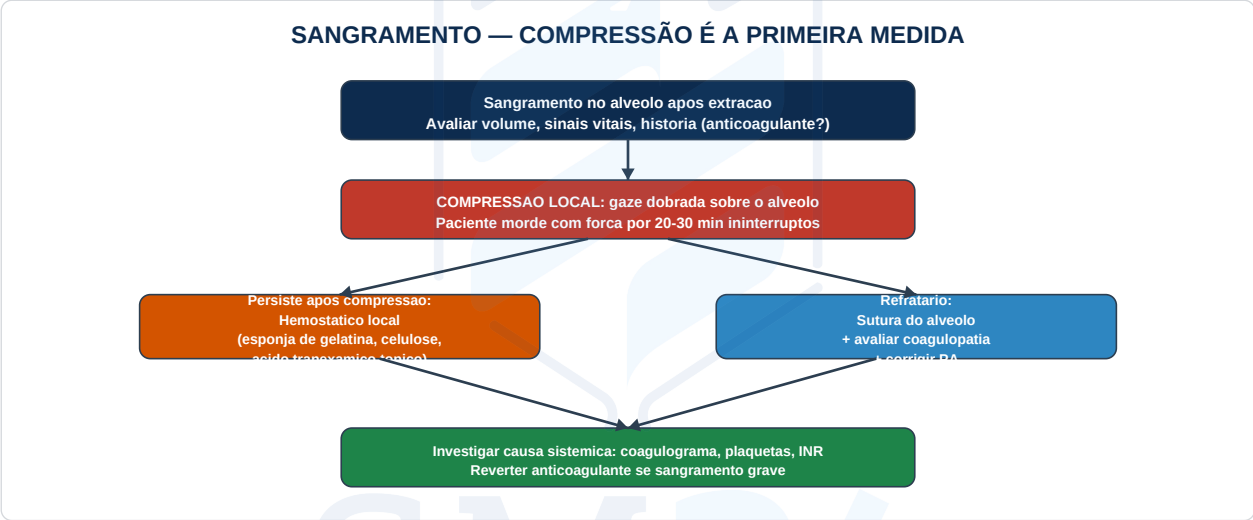


SANGRAMENTO PÓS-EXTRAÇÃO — COMPRIMIR + HEMOSTASIA LOCAL

CAUSAS DE SANGRAMENTO PÓS-EXODONTIA

Categoria	Causas
Locais	Trauma cirúrgico, remanescente de tecido de granulação, fratura óssea/alveolar, vasos lesados
Não remoção do coágulo	Bochecho vigoroso, sucção, manipulação da ferida pelo paciente
Distúrbios de coagulação	Hemofilia, von Willebrand, plaquetopenia, hepatopatia, doença renal
Medicamentos	Anticoagulantes (varfarina, DOACs), antiagregantes (AAS, clopidogrel)
Sistêmicas	Hipertensão não controlada, leucemia, CIVD

MANEJO DO SANGRAMENTO PÓS-EXTRAÇÃO



MÉTODOS DE HEMOSTASIA LOCAL

Método	Como usar
Compressão com gaze	1a medida; morder gaze seca por 20-30 min sem interrupção
Ácido tranexâmico tópico	Embeber gaze em ácido tranexâmico (solução) e morder; ou bochecho 4-7 dias
Esponja de gelatina (Gelfoam)	Colocar no alvéolo; matriz para formação do coágulo
Celulose oxidada (Surgicel)	Hemostático absorvível, colocado no alvéolo
Sutura	Aproximação das bordas gengivais sobre o alvéolo
Eletrocautério/cera óssea	Sangramento ósseo persistente (uso odontológico)

PACIENTE ANTICOAGULADO — CONDUTA

NÃO SUSPENDER ANTICOAGULANTE DE ROTINA

- Varfarina com INR <3,5: extração pode ser feita SEM suspender — controle local da hemostasia é suficiente
- Não suspender anticoagulante de rotina para extração simples (risco trombótico > risco de sangramento)
- Ácido tranexâmico tópico (bochecho) reduz sangramento em anticoagulados sem suspender a droga
- Sangramento grave + varfarina: vitamina K + CCP se com risco de vida (avaliar caso a caso)
- DOACs: hemostasia local geralmente eficaz; idarucizumabe/andexanet apenas em sangramento grave
- Hipertensão não controlada: corrigir PA (vasoconstrição inadequada perpetua o sangramento)

ALVEOLITE — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Alveolite Seca (Dry Socket)

- Perda do coágulo 2-4 dias após a extração (não é sangramento, é dor)
- Dor intensa, irradiada, alvéolo vazio com osso exposto
- Mais comum: terceiro molar inferior, tabagistas, anticoncepcional
- Tratamento: irrigação + curativo com pasta analgésica (eugenol)
- Analgesia + orientação; antibiótico não é necessário de rotina
- Prevenção: evitar fumar, sucção, bochecho vigoroso pós-extração

Orientações de Alta

- Morder gaze por 30 min; trocar se encharcar (sem ficar verificando)
- Não cuspir, não bochechar, não fumar, não usar canudo por 24-48h
- Dieta fria/morna e pastosa nas primeiras 24h
- Não manipular o alvéolo com a língua ou dedos
- Repouso, cabeça elevada ao dormir
- Retornar se: sangramento volumoso persistente, tontura, palidez

ABORDAGEM NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Compressão local com gaze por 20-30 min ininterruptos é a primeira e mais eficaz medida
- ☐ Ácido tranexâmico tópico é muito útil, especialmente em anticoagulados
- ☐ Não suspender anticoagulante de rotina — controle local resolve a maioria dos casos
- ☐ Investigar coagulopatia se sangramento desproporcional ou recorrente (INR, plaquetas, TTPA)
- ☐ Corrigir hipertensão e fatores sistêmicos contribuintes
- ☐ Sutura e hemostáticos absorvíveis para sangramento refratário à compressão

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente retorna ao PS com sangramento no alvéolo 2 horas após extração dentária. Qual é a PRIMEIRA medida?

- A) Suturar imediatamente o alvéolo
- B) Compressão local com gaze, mordendo por 20-30 minutos ininterruptos
- C) Transfundir plaquetas
- D) Suspende qualquer anticoagulante e aguardar
- E) Cauterizar com eletrocautério de imediato

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente em uso de varfarina com INR 2,8 necessita de extração dentária simples. Qual é a conduta correta?

- A) Suspende a varfarina por 5 dias antes do procedimento
- B) Realizar a extração SEM suspender a varfarina (INR <3,5), com hemostasia local + ácido tranexâmico
- C) Substituir varfarina por heparina (bridge) sempre
- D) Contraindicar a extração até INR <1,5
- E) Transfundir plasma fresco antes do procedimento

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com dor intensa 3 dias após extração de terceiro molar, alvéolo vazio com osso exposto e SEM sangramento. Qual é o diagnóstico?

- A) Hemorragia pós-exodontia
- B) Alveolite seca (dry socket) — perda do coágulo
- C) Abscesso periapical
- D) Osteomielite mandibular
- E) Fratura de mandíbula

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual agente, usado topicamente (gaze embebida ou bochecho), é eficaz para controlar sangramento pós-extração, especialmente em pacientes anticoagulados?

- A) Adrenalina tópica
- B) Ácido tranexâmico
- C) Povidona iodada
- D) Peróxido de hidrogênio
- E) Soro fisiológico gelado

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que NÃO se deve suspender rotineiramente o anticoagulante para uma extração dentária simples?

- A) Porque a suspensão não altera o sangramento
- B) Porque o risco de evento tromboembólico pela suspensão supera o risco de sangramento, que é controlável com medidas locais
- C) Porque os anticoagulantes não interferem na hemostasia oral
- D) Porque a extração não causa sangramento
- E) Porque a reintrodução do anticoagulante é difícil

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A primeira e mais eficaz medida no sangramento pós-exodontia é a compressão local: gaze dobrada sobre o alvéolo, mordida com firmeza por 20-30 min ininterruptos. Resolve a maioria dos casos. Se persistir: hemostático local, ácido tranexâmico, sutura, e investigação de coagulopatia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Varfarina com INR <3,5: extração simples pode ser feita SEM suspender o anticoagulante. O risco trombótico da suspensão supera o risco de sangramento, que é controlável com medidas locais (compressão, ácido tranexâmico tópico, esponja hemostática, sutura).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Alveolite seca (dry socket): dor intensa 2-4 dias após extração (mais comum em 3º molar inferior) por perda/desintegração do coágulo, com osso exposto. Não é sangramento. Tratamento: irrigação + curativo com pasta de eugenol + analgesia. Antibiótico não é necessário de rotina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Ácido tranexâmico (antifibrinolítico) tópico — gaze embebida na solução ou bochecho 4x/dia por 4-7 dias — controla eficazmente o sangramento pós-extração, particularmente útil em pacientes anticoagulados, permitindo não suspender a anticoagulação sistêmica.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Suspender o anticoagulante para extração simples expõe o paciente a risco de evento tromboembólico (AVC, TEP), que é mais grave que o sangramento — este é previsível e controlável com hemostasia local. Por isso a conduta atual é manter a anticoagulação e otimizar o controle local.

SM24
Suporte ao Plantão Médico